

PrepaTec | MONMX Hidalgo 2026

OMS Preparatoria

# Background

RAÍCES AL FUTURO

'yu ha rä mäyu

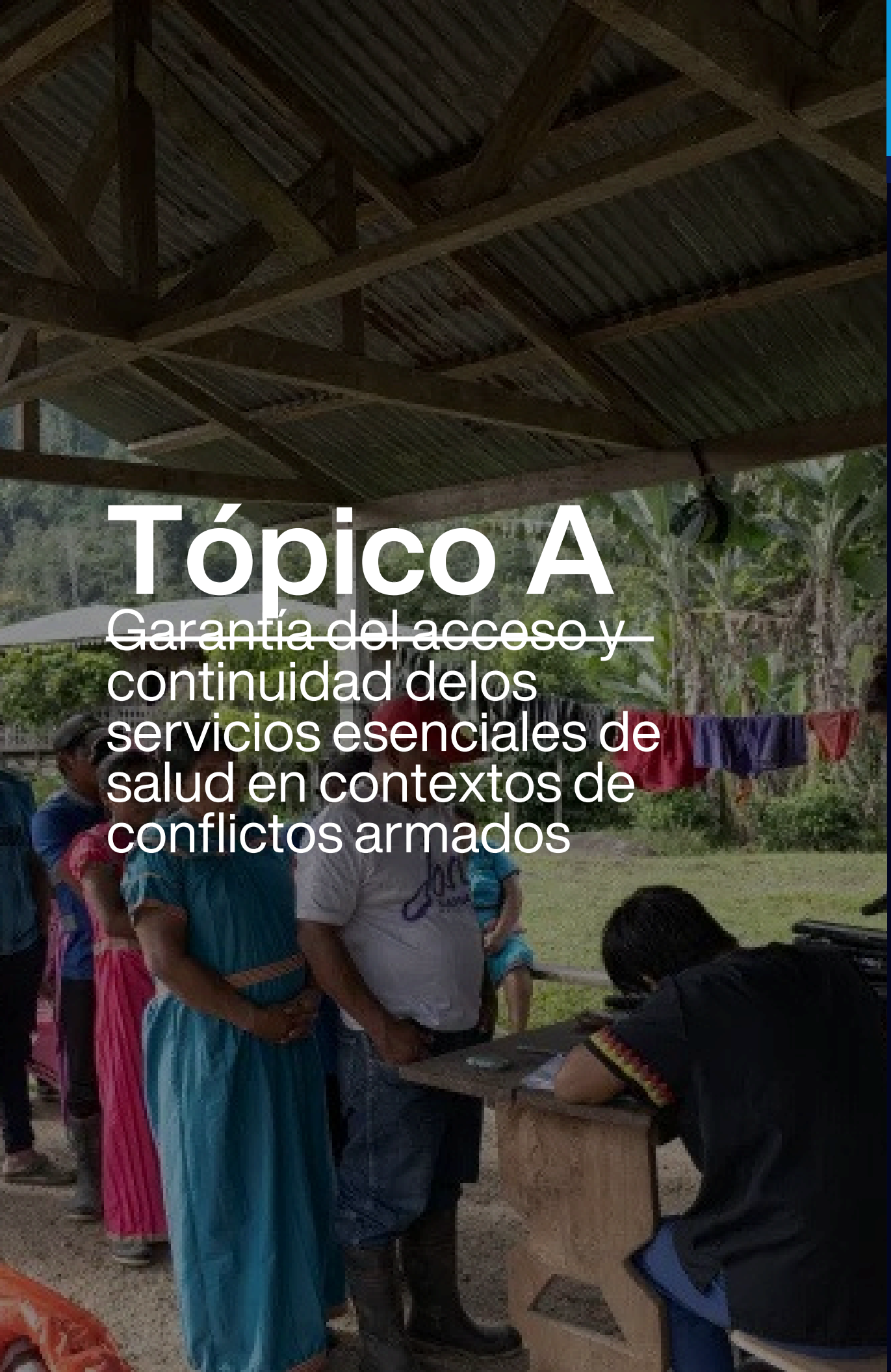
# Introducción al Comité

La Organización Mundial de la Salud (OMS), fundada en 1948 es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de dirigir y coordinar acciones sanitarias a nivel mundial. Su propósito es lograr que todas las personas alcancen el máximo grado posible de salud, mediante normas basadas en evidencia científica y la cooperación de países y asociaciones. En el marco global el comité aborda temas como, la atención de emergencias sanitarias, la protección de los servicios de salud esenciales durante conflictos armados y el apoyo internacional para garantizar un acceso equitativo a medicamentos y vacunas ante crisis que se pueden transformar en catástrofes globales.

Estos asuntos se relacionan estrechamente con la temática de MUNMx26 Campus Hidalgo: Sostenibilidad y Pueblos Indígenas. La OMS reconoce que el bienestar de las personas depende del equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente, por lo que la sostenibilidad es clave para la salud pública global. En este sentido los pueblos indígenas desempeñan un papel fundamental: su cosmovisión y su estrecha relación con la naturaleza han dado a lugar a prácticas de prevención y sistemas de medicina tradicional sus
que mantienen en el cuidado de la salud de
comunidades. Por ello, el comité busca promover políticas y mecanismos de cooperación que garanticen un acceso justo a la salud, respetando sus ideologías y protegiendo el medio ambiente.







# Tópico A

## ~~Garantía del acceso y~~ continuidad delos servicios esenciales de salud en contextos de conflictos armados

## Pregunta rectora

**¿De qué manera la comunidad internacional puede poner fin a la impunidad y garantizar el respeto incondicional a los servicios de salud e infraestructura médica en zonas de conflicto armado?**

Este tópico aborda cómo proteger y asegurar que los servicios de salud sigan operando y sean accesibles para la población en conflictos armados. Existen convenios internacionales que hablan sobre esto como los convenios de Ginebra de 1949, los cuales establecen que la atención médica debe respetarse en todo momento. Sin embargo, el problema central es que estas reglas no siempre se cumplen. Es por eso es que este tema es tan importante, ya que sin atención de salud, la población se queda desprotegida cuando más lo necesita.

Los números muestran que la situación se encuentra en un estado grave. Desde 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado más de 10,000 ataques contra la atención de la salud en 29 países y territorios, entre estos ataques se registraron 5,700 muertos entre personal médico y pacientes. En Gaza, por ejemplo, 32 de sus 36 hospitales han sufrido daños y casi ninguno de los responsables ha tenido que responder por estos hechos.

Durante el debate se discutieron varios puntos centrales. Entre estos como acabar con la impunidad y lograr que los culpables de los ataques asuman su responsabilidad. Así como, se buscarán formas prácticas de proteger y asegurar de que todo servicio de salud no sea afectado por estos conflictos.





"La atención médica no es un objetivo de guerra; el personal de salud no es un objetivo. Proteger la salud en conflictos armados es una obligación legal y moral inquebrantable."
-Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

# Contexto Histórico

La garantía nace con la misma OMS en 1948, cuando la constitución de esta misma entra en vigor; esta constitución establece que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Esta misma comenta que su misión es “alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”, de esa manera mostrando la garantía que tiene la organización desde su fundación con todos los seres humanos para que todos, sin excepciones, puedan gozar de un grado máximo de salud. Más tarde, en el año de 1949, nacieron los Convenios de Ginebra, un documento con el fin de regular el derecho internacional y tomar acción para proteger a los no involucrados en la guerra, así como también a quienes no pueden continuar en el conflicto, dando así un paso para las víctimas de la guerra. Este objetivo se puede apreciar en el artículo 12, que dice: “Habrán de ser respetados y protegidos sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o en cualquier otro criterio análogo”.
Pero la OMS continuó avanzando e impulsando la Resolución 2286 (2016), que exige el fin de la impunidad y el respeto estricto tanto al personal médico como a la infraestructura médica en zonas de combate bélico. Con todo este contexto histórico se puede ver el compromiso de la organización con la garantía, acceso y servicios de salud en contextos de conflicto armado.

Un hito clave fue la aprobación de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad en 2016 tras los continuos ataques a hospitales en zonas como Siria y Yemen para exigir el fin de la impunidad y la protección del personal médico.





# Medidas Tomadas

Las medidas que se han tomado para la solución se han dividido en diferentes secciones, las principales es el marco jurídicos y relaciones interacciones derecho Internacional pertenecíendo la aplicación del Humanitario también conocido como el DIH este derecho exige que los estados o grupos armados respeten a todo personal médico, enfermos y heridos, de igual manera la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo proteger además de castigar a todos aquellos que ataquen a grupos medicas.

Han iniciado iniciativas globales para la protección y alerta: “Asistencia de salud en peligro” liderada por el CICR para la retirada escape de afectados, colectivos de la OMS y Médicos Sin Fronteras (MSF) donde los médicos pueden cruzar sin necesidad de papeles o visas, trabajan colectivamente para visibilizar el impacto de las guerra y poder crear sistemas sanitarios y pasajes seguros.

Otras de las acciones que se han realizado en la negociación humanitaria, en el cual equipos especializados establecen diálogos para generar pausas humanitarias, corredores seguros de evacuación. Mecanismo de atención primario donde clínicas comunitarias móviles y puestos de socorro serán activados con el apoyo de las naciones y diseño adaptativo a una infraestructura resiliente donde se construyen centros de salud con materiales reforzados, bunkeres para salas de cirugía y sistemas de energías solar para no depender de la red eléctrica.






“La medicina no debe convertirse en objetivo de guerra; curar es un acto de humanidad universal.”
-Dr. Denis Mukwege

# Preguntas Guía

1. ¿Cuál eslapostura oficial de su país sobre la protección de los servicios de salud ante conflictos armados y recibir ayuda humanitaria?
2. ¿Qué leyes y políticas nacionales protegen al área de salud en situaciones de conflicto o emergencia?
3. ¿Cómo funciona el sistema de salud en el país públicos y/o privados para el público en general y grupos vulnerables?
4. ¿Qué protocolo sanitario tiene el país en caso de emergencias o de un conflicto armado?
5. ¿La delegación a la cual representa ha respaldado la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos ind ígenas?
6. ¿Cuánto y de qué forma su delegación aporta a la OMS?
7. ¿Su delegación ha participado en un conflicto armado?
8. ¿Qué posturas o iniciativas ha tenido su delegación ante la ayuda comunitaria y la protección de grupos vulnerables?
9. ¿Qué barreras enfrenta su delegación para proteger y mantener en funcionamiento los servicios de salud ante un conflicto armado?
10. ¿Qué delegaciones han votado o propuesto de forma similar o conjunto ante resoluciones sobre la salud y protección de la población?



# Tópico B

## ~~Cooperación~~ internacional para garantizar el acceso equitativo a recursos médicos esenciales ante futuras pandemias.

## Pregunta rectora

**¿Cómo garantizar que la distribución de vacunas y recursos médicos en futuras pandemias sea equitativa y no dependa de la capacidad económica de cada país?**

Este tópico trata de cómo lograr que todos los países y territorios tengan acceso a vacunas, medicamentos, y servicios de salud en general en caso de que llegue alguna futura pandemia.

El tema central es la cooperación internacional para que se evite lo ocurrido en durante la pandemia de COVID-19, cuando los países y territorios con menos países tuvieron que esperar. Es por eso que este tema es relevante, ya que las pandemias no esperan mientras que la población no tiene cómo defenderse ante estas situaciones.

En mayo de 2025 la Asamble Mundial de la Salud sobre Pandemias de la OMS aprobó el acuerdo sobre pandemias de la OMS que busca que el mundo esté mejor preparado ante futuras pandemias. Sin embargo, falta definir un tema clave, el cual es garantizar que las muestras de patógeno se repartan rápidamente y cómo asegurar que los países reciban las vacunas y tratamientos que se desarrollan a partir de estas muestras.

Segun ya mencionado, la OMS durante la pandemia de COVID- 19 se creó COVAX que se encarga de repartir vacunas en los países con menos recursos. COVAX logró entregar más de 2,000 millones de dosis a 146 países y territorios, aunque no logró acabar con la desigualdad ya que algunos países los recibieron .






> “Ninguna nación está segura hasta que todas las naciones estén seguras; la equidad en el acceso a la salud es la única defensa real ante una pandemia.”
> -Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

# Contexto Histórico

En 1969 la OMS crea el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que fue uno de los primeros antecedentes para la prevención de enfermedades a nivel mundial. Posteriormente, en el año de 2005, se crearía el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), que tenía como fin obligar a los Estados vinculantes a advertirle a la OMS cualquier emergencia de sanidad pública relevante, así como también dar recomendaciones claras a las naciones del mundo de cómo prevenir, protegerse, controlar y dar una respuesta contra la propagación de la enfermedad a nivel internacional. Así, con este reglamento establecido en este siglo se darían muchos avances a la hora de enfrentarse contra las epidemias.

El mundo con estas medidas lograría controlar diversas situaciones hasta que llegara el año de 2020 con la llegada del virus SARS-CoV-2, que generaría una pandemia de escala global. Con la llegada de este mismo, la OMS activaría el mecanismo COVAX, que sería una colaboración entre la OMS, Gavi y CEPI, que tendría el fin de crear un fondo de inversión global que reunió a más de 190 países con el fin de distribuir vacunas a todo el mundo, con énfasis en los países subdesarrollados, distribuyendo alrededor de 2000 millones de vacunas a escala mundial.

Asimismo, con ese suceso nació el acuerdo sobre pandemias para la prevención, preparación y respuesta en cuanto a futuras pandemias, como también crear un marco jurídico para evitar la desigualdad que se vivió con el SARS-CoV-2 con el reparto de vacunas

La evolución histórica de la seguridad sanitaria global comenzó con el Reglamento Sanitario Internacional de 1969 y su actualización en 2005 para alertar sobre emergencias, consolidándose en 2020 con el mecanismo COVAX frente al COVID-19 y culminando en el reciente acuerdo de pandemias de la OMS para evitar desigualdades globales en el acceso a vacunas.

# Medidas Tomadas

Durante los últimos años, la OMS y sus Estados Miembros han tomado diferentes medidas para mejorar la cooperación internacional y lograr un acceso más equitativo a vacunas, medicamentos y otros recursos médicos durante las pandemias.

Una de ellas es el “Marco de Preparación para una Gripe Pandémica (PIP)”, adoptado en 2011. Este mecanismo busca que los países compartan información y muestras de virus con potencial pandémico, mientras se facilita el acceso a vacunas, medicamentos y diagnósticos necesarios durante una emergencia sanitaria.

Durante la pandemia de COVID-19 también se creó “COVAX”, una iniciativa coordinada por la OMS, Gavi y CEPI, con UNICEF como socio para la distribución. Su objetivo fue apoyar el desarrollo y distribución vacunas y ayudar a que estas llegaran a países que tenían mayores dificultades para conseguirlas.

Otra medida importante fue el “Acuerdo de la OMS sobre Pandemias”, aprobado el 20 de mayo de 2025. Este acuerdo busca mejorar la prevención y respuesta ante futuras pandemias, fortaleciendo la cooperación entre países y promoviendo un acceso más justo a los recursos médicos.

En conjunto, estas medidas buscan reducir las desigualdades entre países y lograr que la respuesta ante una futura pandemia no dependa únicamente de la capacidad económica de cada nación.



“La preparación no es un costo, es una inversión en nuestro futuro; la solidaridad entre naciones es la mejor vacuna contra las pandemias”
-Dr. Seth Berkley

# Preguntas Guía

1. ¿Quédificultadexisteensu delegación para extender los servicios médicos?
2. ¿Cuál ha sido la postura del país con respecto a la distribución de vacunas?
3. ¿Cuál es el porcentaje del PIB destinado a la Salud Pública?
4. ¿Qué medidas ha tomado el país ante futuras pandemias?
5. ¿Qué recursos médicos esenciales necesita importar el país?
6. ¿Cuál es la postura del país ante la producción y creación de vacunas?
7. ¿Cuál fue la postura del país durante las negociaciones sobre el acuerdo de Pandemias de la OMS?
8. ¿Qué dificultades enfrentó el país para obtener recursos médicos en pandemias anteriores?
9. ¿Cómo abordó el país ante la desigualdad de insumos médicos?
10. ¿Qué propuestas ha proporcionado el país ante organismos internacionales para la distribución de recursos médicos?

# Referencias

Acuerdosobreprevención,preparaciónyrespuesta frente a pandemias. (s. f.). https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/pandemic-preventior preparedness-and-response-accord

Bendavid, E., Boerma, T., & Akseer, N. (2021). The effects of armed conflict on the health women and children. The Lancet, 397(10279), 1133-1144. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00131-8/fulltext

Brennan, R., Martinez, E., Rubenstein, L., Kim, H. J., El Akoum, M., Afdhal, S., Guevara, M., S., Bashford, T., Slama, S., & Musani, A. (2024, noviembre). In the line of fire: Protecting he armed conflict. World Innovation Summit for Health. https://cdn.who.int/media/docs/def source/health-workforce/hwp/in-the-line-of-fire-(1).pdf?sfvrsn=5d437b90_3&downloac

Comité Internacional de la Cruz Roja. (s. f.). Los Convenios de Ginebra y sus comentarios. Recuperado de https://www.icrc.org/es/derecho-y-politicas/los-convenios-de-ginebra- comentarios

Cruz Roja Americana. (s. f.). Resumen de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protoc Adicionales. Recuperado de https://www.redcross.org/content/dam/redcross/enterpris assets/cruz-roja/cruz-roja-pdfs/Resumen-de-los-Convenios-de-Ginebra-de-1949-y-sus Protocolos-Adicionales.pdf

Estrategias para asegurar el acceso a los servicios de salud: superar barreras y garantiza continuidad. (s. f.). OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/eventos/estrategias-para-asegurar-acceso-servicios-salud- superar-barreras-garantizar-continuidad

Gavi, the Vaccine Alliance. (s. f.). COVAX. Recuperado de https://www.gavi.org/covax In the Line of Fire: Protecting Health in Armed Conflict. (s. f.). https://www-who- int.translate.goog/publications/m/item/in-the-line-of-fire--protecting-health-in-armed-c _x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge

Médicos Sin Fronteras. (2026, 5 mayo). Hacemos un llamado conjunto del CICR, la OMS para que los Estados respeten la Resolución 2286. Médicos Sin Fronteras En México y Centroamérica. https://msf.mx/actualidad/hacemos-un-llamado-conjunto-del-cicr-la-om msf-para-que-los-estados-respeten-la-resolucion-2286/

# Referencias

OrganizaciónMundialdelaSalud.(s.f.).Acerca de la historia de la OMS. Recuperado de https://www.who.int/es/about/history

Organización Mundial de la Salud. (s. f.). El acuerdo sobre pandemias de la OMS. Recuper de https://www.who.int/es/health-topics/who-pandemic-agreement#tab=tab_1

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Surveillance System for Attacks on Health Care ( [Panel de datos]. Recuperado el 1 de octubre de 2026 de https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx

Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. (2024, septiembre). oPt emergency situation update (Núm. 46). https://www.emro.who.int/opt/information-resources/emergency-situation-reports.htm

Organización Mundial de la Salud. (s. f.). El acelerador ACT y COVAX. Recuperado de https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax

Organización Mundial de la Salud. (2015). Documentos básicos (49.ª ed.). https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-sp.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2023). Reglamento Sanitario Internacional (2005) (3.ª https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/IHR_2022-sp.pdf

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). WHO Pandemic Agreement. Recuperado el 1 de octubre de 2026 de https://www.who.int/health-topics/pandemic-agreement

Organización Mundial de la Salud. (2023, 19 de diciembre). COVID-19 vaccinations shift t regular immunization as COVAX draws to a close. https://www.who.int/news/item/19-12 2023-covid-19-vaccinations-shift-to-regular-immunization-as-covax-draws-to-a-close

Respetar y proteger la asistencia de salud en conflictos armados y en situaciones que no regidas por el DIH. (2012). En CICR. https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/respetar-y-proteger-la-asiste de-salud-en-conflictos-armados-y-en-situaciones-que-no-estan-regidas-por-el-derecho internacional-humanitario-ficha-tecnica.pdf

World Health Organization: WHO. (2015, 4 noviembre). Poner fin a la violencia, proteger l asistencia de salud. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news/iter 11-2015-stop-the-violence-protect-health-care